

表2 喘息の治療開始前の重症度と、重症度別治療指針\*\*

| 治療前重症度* | 軽症                                                                                                             | 中等症以上                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 症 状     | 症状は毎日ではない<br>日常生活や睡眠への妨げ：週 1 回未満<br>夜間症状：週 1 回未満                                                               | 症状が毎日ある<br>日常生活や睡眠への妨げ：週 1 回以上<br>夜間症状：週 1 回以上                                                                          |
| 長期管理薬   | 中用量 ICS/LABA を基本とする<br>ICS+LAMA や ICS+LTRA も選択可<br><br>症状が軽度であれば ICS 中用量単剤や、<br>ICS が使用できない場合は LTRA 単剤も<br>選択可 | 中～高用量 ICS/LABA に、必要に応じて以下のいずれか 1 剤あるいは複数を追加：LAMA（トリプル配合剤の使用可）、LTRA、テオフィリン徐放製剤<br>LTRA 以外の抗アレルギー薬（抗トロンボキサン薬など）の追加も考慮してよい |
| 増悪治療    | 吸入 SABA 頓用（SAMA も使用可）<br>BUD/FOM を長期管理薬として用いる場合はその頓用<br>効果不十分なら短期 OCS                                          | 吸入 SABA 頓用（SAMA も使用可）<br>BUD/FOM を長期管理薬として用いる場合はその頓用<br>効果不十分なら短期 OCS（治療導入時に症状が強い場合、数日間併用してもよい）                         |

\*軽症は『喘息予防・管理ガイドライン 2024』の治療ステップ 1・2、中等症以上は治療ステップ 3・4 に該当する。

\*\*各症例の treatable traits も考慮しながら本指針に準じて治療を開始する。再評価時に咳のコントロールが不十分であれば treatable traits も考慮して治療を強化する。

ICS：吸入ステロイド薬、LABA：長時間作用性 $\beta_2$ 刺激薬、LAMA：長時間作用性抗コリン薬、LTRA：ロイコトリエン受容体拮抗薬、SABA：短時間作用性 $\beta_2$ 刺激薬、BUD：ブデソニド、FOM：ホルモテロール、OCS：経口ステロイド薬。

〔日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025 作成委員会（編）：咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025，メディカルレビュー社，p110，2025 より転載〕

後に再評価してステップアップ/ダウンを検討する。治療開始時と、効果不十分でステップアップを検討する際には、画一的な治療薬の選択や追加・増量に留まらず、個々の患者で重点的に治療すべき特性（treatable traits）も考慮する<sup>1)</sup>。

#### a 軽症例の治療

中用量 ICS/LABA で加療する。吸入でかえってむせたり効果が乏しい場合は、他の製剤への変更も考慮する。LABA が副作用で使用しにくければ ICS+long-acting muscarinic antagonist（LAMA）や ICS+ロイコトリエン受容体拮抗薬（leukotriene receptor antagonist：LTRA）も選択できる。症状が軽度なら ICS 中用量単剤や、ICS を使用しにくければ LTRA 単剤を使用する<sup>1)</sup>。

#### b 中等症以上

中～高用量 ICS/LABA に LTRA，LAMA 追加（トリプル配合剤使用可）、テオフィリン徐放製剤追加や、ICS，ICS/LABA の高用量への増量を検討する。中～高用量 ICS/LABA 使用下に特に日中の咳が残存する場合は、咳受容体感受性亢進の関与を想定し LTRA や LAMA を積極的に追加する<sup>1,3)</sup>。しばしば合併する胃食道逆流症の治療も考慮する<sup>1,2,4)</sup>。難治例では P2X3 受容体拮抗薬も選択肢となる<sup>5)</sup>。

#### c 悪化時の治療

上気道炎などによる悪化時や連夜の睡眠障害など症状が強い場合には、SABA 頓用と短期経口ステロイド薬を併用する。

#### d 予後と長期治療<sup>1)</sup>

治療が不十分な場合に約 30% に認める典型的喘息への移行は、診断時からの ICS 使用で減少する。大多数の症例では、咳は ICS を中心とする治療で速やかに軽快し、薬剤を減量できるが、中止によりしばしば再燃する。難治例、症状持続例では必然的に長期の治療継続が必要であり、アドヒアランスも保たれる。

一方、治療開始後短期間で症状が軽快、消失した場合の治療期間にはエビデンスはない。非専門施設においても治療継続が推奨されるが、過去数年以上再現性を持って一定の季節にだけ咳症状が生じていれば、症状の生じる時期に治療を開始し、季節を過ぎれば治療を止めてよい。通年性に症状があるか、初発で季節性の有無が不明なら 2～3 ヶ月ごとに評価して（ほぼ）無症状なら ICS 以外の長期管理薬を 1 剤ずつ減らし、さらに ICS を半減していく。1 年以上の治療後に ICS の最低用量で無症状なら中止を考慮してもよい<sup>1)</sup>。

#### 文 献

- 1) 日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025 作成委員会（編）：咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025，メディカルレビュー社，2025
- 2) 新実彰男：日内会誌 **105**：1565，2016
- 3) Niimi A, et al：Pulm Pharmacol Ther **59**：101854，2019.
- 4) Niimi A：Pulm Pharmacol Ther **47**：59，2017
- 5) Matsumoto H, et al：ERJ Open Res **11**：01037–2024，2025